



寨卡病毒

2025年11月6日 | 阅读时间 13 分钟 (3442 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

重要事实

- 寨卡病毒主要由伊蚊传播。伊蚊主要在白天叮咬。
- 大多数寨卡病毒感染者不会出现症状。如果出现症状，症状通常为皮疹、发烧、结膜炎、肌肉和关节疼痛、不适和头痛，持续 2-7 天。目前尚无可用于预防或治疗寨卡病毒感染的疫苗。
- 怀孕期间感染寨卡病毒可导致婴儿出生时发生小头畸形和其他先天性畸形或发生早产和流产。
- 寨卡病毒感染与成人和儿童的吉兰 — 巴雷综合征、神经病变和脊髓炎有关。
- 2016年2月，世卫组织宣布寨卡病毒相关小头症为国际关注的突发公共卫生事件。寨卡病毒与先天畸形之间的因果关系被证实。2016年11月，世卫宣布此问题不再是国际关注的突发公共卫生事件。
- 自2017年以来全球寨卡病毒病例有所下降，但在美洲多个国家以及亚洲和非洲的一些国家，仍存在低度传播问题，发生了零星疫情。

概述

寨卡病毒是一种蚊媒病毒，1947年在乌干达的恒河猴中首次发现，随后1950年代在其他非洲国家发现了人类感染和患病的证据。

从1960年代到1980年代，非洲和亚洲都发现过零星的人类感染。自2007年以来，非洲、美洲、亚洲和太平洋地区都有寨卡病毒病疫情记录。

在过去十年的历次疫情中，发现寨卡病毒感染与吉兰 — 巴雷综合征发病率增加有关。2015年，寨卡病毒在美洲出现，巴西发生大规模流行。当时首次认识到寨卡病毒感染与小头畸形（小于正常头部尺寸）之间存在关联。回顾性审查结果发现，在法属波利尼西亚也存在类似现象。2016年2月至11月，世卫组织宣布小头症、其他神经系统障碍和寨卡病毒为国际关注的突发公共卫生事件。

此后不久，寨卡病毒与先天性畸形之间的因果关系得到证实(1, 2)。在美洲大部分地区以及其他存在埃及伊蚊种群的区域，均发现了寨卡病毒病疫情。还在来自活跃传播地区的旅行者中发现了感染。性传播被确认为寨卡病毒感染的另一途径。

全球寨卡病毒病例从2017年起有所下降。不过，寨卡病毒仍在美洲几个国家和其他地方性流行区域保持低水平流行。此外，2019年欧洲报告了首批本地蚊子传播的寨卡病毒病例。在一些国家发现了寨卡病毒疫情活动。迄今为止，共有92个国家和地区报告过蚊子传播寨卡病毒感染的证据；然而，全球监测仍然有限。

症状

大多数寨卡病毒感染者不会出现症状。如果生病，症状通常在感染后3至14天内出现。症状通常比较轻微，包括皮疹、发烧、结膜炎、肌肉和关节疼痛、不适和头痛等，通常持续2-7天。这些症状在其他虫媒病毒和非虫媒病毒性疾病中也很常见；因此，诊断寨卡病毒感染需要实验室确认。

并发症

怀孕期间感染寨卡病毒是造成婴儿小头畸形和其他先天性畸形（包括肢体挛缩、高肌张力、眼睛异常和听力损失）的原因之一。这些临床特征统称为先天性寨卡综合征。

妊娠期感染后发生先天性畸形的风险仍然未知；据估计，怀孕期间感染寨卡病毒的妇女所生婴儿中有5%-15%有寨卡相关并发症的证据(3)。先天性畸形发生在有症状和无症状感染后。妊娠期寨卡病毒感染也可引起并发症，如胎儿流产、死产和早产。

寨卡病毒感染还可能导致吉兰—巴雷综合征、神经病变和脊髓炎，特别是在成人和年龄较大儿童中。

目前正在进行研究，以调查寨卡病毒感染对妊娠结局的风险和影响、预防和控制策略以及感染对儿童和成人其他神经系统障碍的影响。

传播

寨卡病毒主要由伊蚊（剑纹伊蚊）属蚊子（主要是埃及伊蚊和白纹伊蚊）传播；这些蚊子还传播登革热、基孔肯雅热和城市黄热病。这些蚊子在热带和亚热带地区最多，但其地理分布范围正在扩大。伊蚊通常在白天叮咬。它们主要在户外活动，但也可能在室内觅食。

寨卡病毒还会在妊娠期从母亲传播给胎儿，以及通过性接触、实验室暴露、输血和输注血液制品，并可能通过器官移植传播。

诊断

根据居住在或访问寨卡病毒传播地区和/或伊蚊媒介地区的人的症状，可以怀疑寨卡病毒感染。寨卡病毒感染的诊断只能通过[实验室检测](#)血液或其他体液进行确认，可采用逆转录聚合酶链反应方法检测病毒核糖核酸，或检测IgM抗体。IgM抗体检测阳性结果必须与交叉反应性相关黄病毒（如登革热病毒）进行鉴别诊断。患者可能接触过黄病毒或接种过相关疫苗。

治疗

没有针对寨卡病毒感染或疾病的特异性治疗方法。

有皮疹、发烧或关节疼痛等症状的人应充分休息，多喝水，并用解热药和/或镇痛药对症治疗。如果无法做出具体诊断且无法排除登革热，应根据标准化临床指南，对患者视同登革热患者进行治疗。由于存在出血风险，在排除登革热病毒感染之前，应避免使用非甾体抗炎药。如果症状恶化，患者应求医和寻求医疗建议。

生活在寨卡传播地区或出现寨卡病毒感染症状的孕妇应就医，以进行实验室检测、获得信息、咨询和其他临床医疗服务。

预防

目前尚无可用于预防或治疗寨卡病毒感染的疫苗。寨卡疫苗的开发仍然是一个活跃的研究领域。

蚊虫叮咬

白天和傍晚防止蚊虫叮咬是预防寨卡病毒感染的关键措施，特别是在孕妇、育龄妇女和幼儿中。

个人防护措施包括穿着尽可能多地覆盖身体的衣服（最好是浅色）；使用物理屏障，如安装纱窗和关闭门窗；根据产品标签说明在皮肤或衣服上涂抹含有避蚊胺、驱蚊酯或埃卡瑞丁的驱蚊剂。

幼儿和孕妇如果在白天或傍晚睡觉，应睡在蚊帐里。旅行者和生活在受影响地区的人们应采取上述基本预防措施，以保护自己免受蚊虫叮咬。

伊蚊可在家庭、学校和工作场所周围的少量积水中繁殖。必须设法消除这些蚊子滋生场所，包括：覆盖蓄水容器，清除花盆中的积水，清理垃圾和用过的轮胎。社区举措至关重要，可支持开展地方政府和公共卫生规划以减少蚊子滋生场所。卫生主管部门还可建议使用杀幼虫剂和杀虫剂，以减少蚊子数量和疾病传播。

预防性传播

对于寨卡病毒传播活跃的地区，所有寨卡病毒感染者及其性伴侣（特别是孕妇）都应获得有关寨卡病毒性传播风险的信息。

世卫组织建议向性活跃的男女提供咨询服务以及各种避孕方法，使其能够就是否以及何时怀孕做出知情选择，以预防可能的不良妊娠和胎儿结局。

对于在无保护性行为之后因害怕感染寨卡病毒而不希望怀孕的女性，应随时提供紧急避孕服务和咨询。孕妇应至少在整个怀孕期间采取安全的性行为做法（包括坚持正确使用避孕套）或戒除性活动。

对于寨卡病毒传播不活跃的地区，世卫组织建议从寨卡病毒传播活跃地区返回的男性和女性分别在三个月和两个月中采取安全性行为做法或者禁欲，以防止性伴侣感染。居住在发生寨卡病毒本地传播地区或从此类地区返回的孕妇的性伴侣应在整个孕期采取安全性行为或杜绝性活动。

世卫组织的应对

世卫组织通过实施[全球虫媒病毒倡议](#)支持各国对虫媒病毒进行监测和控制，该倡议与[寨卡病毒战略应对计划](#)中提出的建议一致并有所扩展。

世卫组织采取以下措施应对寨卡病毒病：

- 通过其合作实验室网络支持各国确认疫情；
- 为有效管理蚊传疾病疫情向各国提供技术支持和指导；
- 审查新工具开发情况，包括杀虫剂产品和应用技术；
- 制定基于证据的策略、政策和疫情管理计划；
- 为有效管理病例和疫情向各国提供技术支持和指导；
- 支持各国改进其报告体系；
- 与本组织的有关合作中心合作，在区域一级提供临床管理、诊断和病媒控制培训；以及
- 发布供会员国使用的流行病学监测、实验室、临床病例管理和病媒控制指南和手册。

参考文献

1. de Araújo TVB, Ximenes RA de A, Miranda-Filho D de B, et al. Association between microcephaly, Zika virus infection, and other risk factors in Brazil: Final report of a case-control study. *Lancet Infect Dis.* 3099(17)30727-2
2. Krauer F, Riesen M, Reveiz L, et al. Zika Virus Infection as a Cause of Congenital Brain Abnormalities and Guillain–Barré Syndrome: Systematic Review. *PLoS Med.* 2017;14(1). doi:10.1371/journal.pmed.10022
3. Pérez EA, Ticona JA, Alger J, Aranda CA, Niño AA, Ansusinha E, Araújo T, Arias J, Nieto LA, Ávila M, Bardají A. Adverse fetal and perinatal outcomes associated with Zika virus

infection during pregnancy: an individual participant data meta-analysis.

EClinicalMedicine. 2025 May 1;83.

4. Musso D, Ko AI, Baud D. Zika Virus Infection – After the Pandemic. *N Engl J Med*. 2019;381(15). doi:10.1056/nejmra1808246
5. Rabe IB, Hills SL, Haussig JM, et al. A Review of the Recent Epidemiology of Zika Virus Infection. *Am J Trop Med Hyg*. 2025;112(5):1026-1035. Published 2025 Feb 11. doi:10.4269/ajtmh.24-0420